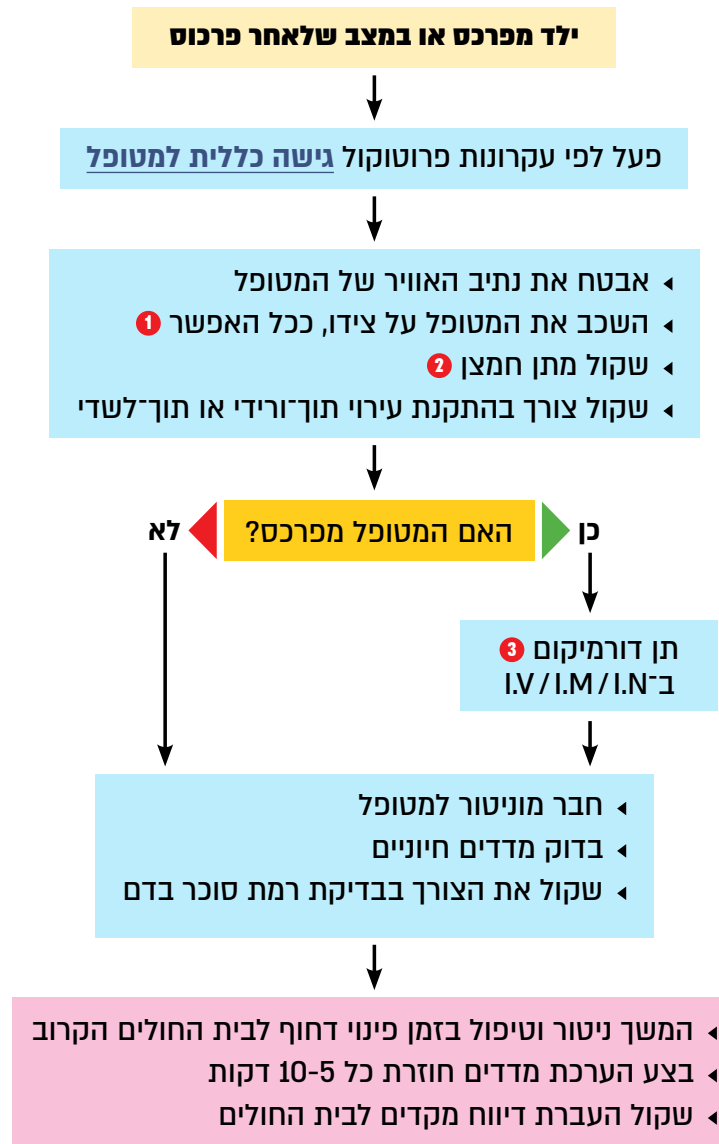




1 **השכבת המטופל על צידו, לשם מניעת אספירציה.**

שימוש בריפוד להגנה ולמניעת חבלת ראש אצל המטופל.

2 **חמצן**

+ מתן חמצן כדי לשמור על ערכי סטורציה בטווח של 94%-99%.

3 **דורמיקום**

+ מינון למתן ב-I.V – 0.1 mg/kg. מנה מקסימלית 5 mg.

+ מינון למתן ב-I.M / I.N –

0.2 mg/kg, עד למקסימום של 10 mg.

+ אם הפרנס נמשך אפשר לחזור על המנה לאחר 5 דקות

במתן ב-I.V ולאחר 10 דקות במתן ב-I.M או I.N.

+ אין לעבור על מינון כולל של 5 mg במתן ב-I.V או 10 mg

במתן ב-I.M / I.N.

+ לאחר מתן דורמיקום יש לעקוב אחר לחץ הדם. במקרה

של ירידה בלחץ הדם יש לתת עירוני נוזלים במינון

20 ml/kg.

היפוגליקמיה

+ אם ערכי הסוכר בדם נמוכים מ-60 mg%, יש לתת

גלוקוז ב-I.V במינון 0.2-0.5 gr/kg (מנה מקסימלית

12.5 gr).

+ ריכוז תמיסת הגלוקוז עד 10%.

+ יש לשוב ולבדוק את ערכי הסוכר בדם כעבור 5-10

דקות.

+ אם ערכי הסוכר בדם של המטופל עדיין נמוכים – אפשר

לתת מנת גלוקוז נוספת (מחצית הכמות).

דגשים נוספים באבחנה ובטיפול

רובם המכריע של הפרוכוסים יסתיימו עצמונית בתוך 5 דקות. קיים סיכוי של 6% להתקף חוזר בתוך 24 שעות.

פרוכסי חום

- + מופיעים בילדים בני 6 חודשים עד 5 שנים. 2%-5% מהילדים יחוו לפחות פרוכוס חום אחד בחייהם. הסיכוי להופעת הפרוכוס עולה ככל שטמפרטורת הגוף עולה על 38°. קיימת נטייה גנטית לפרוכסי חום.
- + אם הפרוכוס חלף, הילד בהכרה מלאה ואין חסרים נוירולוגיים – אין צורך לפעול להשגת גישה ורידית או לבדוק את רמת הגלוקוז בדם.
- + סטטוס אפילפטיקוס הוא פרוכוס הנמשך למעלה מ-5 דקות ברציפות או רצף פרוכוסים עוקבים מבלי שהמטופל חוזר להכרה מלאה ביניהם.

סיבוכים

- + שיעור התמותה כתוצאה מפרוכוס מתמשך או מפרוכוסים חוזרים הוא 4%-6% בממוצע.
- + סוגי הסיבוכים האפשריים (בשיעור של עד 30%) – היפרתרמיה, בצקת ריאות, הפרעות קצב, חסרים נוירולוגיים ממוקדים (כגון חולשה או שיתוק), אנצפלופתיה, רבדומיוליזיס.

דגשים לתשאול המטופל וסביבתו –

- + יש לברר אם המטופל סובל ממחלות רקע, כגון אפילפסיה, סוכרת, מחלת חום שאירעה לאחרונה, מחלות לב, גידולים במוח.
- + יש לברר אם המטופל מדווח על הופעת "Aura" טרם ההתקף; האם יש מחלת חום; האם יש מקרי אפילפסיה במשפחה; האם הפרוכוס מוקדי (פוקלי); האם היה אובדן שליטה על הסוגרים; האם הפרוכוס כלל תנועות טונית-קלוניות; האם נגרמה חבלה כתוצאה מהפרוכוס; האם המטופל נוטל טיפול תרופתי קבוע.

דגשים לביצוע הבדיקה הגופנית –

- + יש להעריך את מצב ההכרה של המטופל; האם נתיב האוויר שלו פתוח; האם נצפים חסרים נוירולוגיים; האם יש סימני חבלה חיצוניים.
- + סטיית מבט קבועה המלווה בחוסר הכרה ובטכיקרדיה יחסית – אלה יכולים להעיד על פרוכוס מתמשך (ongoing).
- + אין להכניס אצבעות לפיו של מטופל מפרכס או במצב שלאחר פרוכוס בניסיון לפתוח נתיב אוויר.